心臓超音波で指摘できた大動脈弁の特殊弁尖形態異常を呈した２症例

◎藤原 真喜[1)]、近藤 遼佳[1)]、安田 慈[1)]、北洞 久美子[1)]、長谷川 千恵[1)]、橋ノ口 由美子[1)]
大垣市民病院[1)]

大動脈弁における先天性心疾患の１つとして、二尖弁などの弁尖形態異常があげられる。年齢を重ねるにつれて、大動脈弁狭窄症や大動脈弁閉鎖不全を引き起こす可能性があり、心不全を契機に発見されることもある。四尖弁は非常にまれな疾患である。二尖弁では癒合(raphe)の数や位置により 3 タイプに分類する Sievers 分類(Type 0-2)、四尖弁では各弁尖の相対的な大きさや形により 7 タイプに分類する Hurwitz らの分類(Type A-G)が広く用いられている。

症例 1 :70 歳男性。心室性期外収縮で外来経過観察中であった。20xx-7 年の経胸壁心臓超音波検査(以下、TTE)で左心系の拡大と中-高度大動脈弁逆流を認めた。その時に四尖弁も指摘されたが左室収縮能(以下、LVEF)は保たれており、引き続き外来経過観察となった。20xx 年に行われた TTE で LVEF42％と低下、左室拡張末期径(以下、LVDd)48.8 mm と以前より拡大傾向であったため精査目的で経食道超音波検査(以下、TEE)が行われた。TEE の結果、中等度の大動脈弁逆流と副冠尖と思われる余剰弁尖を含めた 4 枚の弁尖を認めた。Hurwitz らの分類で Type A と考えられた。

症例２:81 歳男性。息切れを主訴に当院受診。心電図は洞調律、胸部レントゲン検査で心拡大と胸水貯留を認めた。TTE では LVEF44％と低下、LVD d 58.0mm と左室拡大、中-高度大動脈弁逆流を認め、心不全加療目的で入院となった。心臓カテーテル検査では冠動脈造影に異常はなく、大動脈造影で高度大動脈弁逆流を認めた。TEE では、右冠尖-無冠尖間に完全癒合、無冠尖-左冠尖間に不完全癒合を認め、Sievers 分類で Type 2 に近いと考えられた。心不全が軽快して退院、後日大動脈弁置換術が行われた。術中所見も TEE の所見と同様であった。

考察:大動脈弁の形態を正確に評価することは治療方針に影響を与える可能性があり重要である。今回の 2 症例において、弁尖の形態異常を指摘し、詳細な評価を実施できたため、超音波検査は治療方針決定に有用であった。